

⇒신경정신과학 SUMMARY 사용법

- 추가 설명: **파랑**
- 강조: **빨간색** 밑줄
- 말없이 지나간 부분 OR 교과서 내용: 회색
- 이번주차는 1시간 이도은 교수님 수업, 2시간 이비안 한의원 특강으로 진행되었습니다.
- 중풍 후 우울 파트는 이번년도에 처음 추가된 내용입니다.

[1] 중풍 후 우울

Poststroke depression 중풍 후 우울

현대의학의 뇌졸중 = 한의학의 중풍

우리 몸이 흔들리고 마비되는 것을 한의학에서는 풍사로 인한 것으로 봤다.

중풍환자의 심리상태

1) 급성기 중풍환자의 심리상태

- 생사에 대한 공포체험이 아주 강렬

하루아침에 누워지내게 되었고, 견딜 수 없는 두통, 어지럼증, 의식소실 등 뇌졸중의 특징적인 증상 등이 강렬하게 다가옴.

- 중풍은 대개 급작스럽게 발병, 위중, 많은 후유증. 극심한 스트레스 상태에 처하게 됨.
- 급성기를 넘기더라도 중풍 발병과 후유증에 따르는 상실을 받아들이지 못하여 불안이 우울로 발전하고 고독하여 버림받은 느낌이 들고 살아도 쓸모 없다는 생각을 하게 됨.
- 환자는 비관하여 실망하며 무력감이 들고 식욕이 없으며 수면장애가 있고 어린애와 같아지고 이기적이며 제어할 수 없는 억제성 적개심 경향을 보이게 됨

2) 회복기와 재활기 심리상태

- 편마비로 인한 기능상실 때문에 환자는 종종 소극적인 정서가 되어 있어 의지가 약해지고 심각한 의존심리가 생김
- 병이 재발할까 지나치게 걱정하고 의료진의 치료 및 보호자의 도움에 의존하게 됨

- 재활기에는 곧 직면할 장기적인 치료를 받아들이기 어렵고 또한 사회경제적인 부담 때문에 심리적인 위축과 우울감을 나타내게 됨.

중풍 때문에 원래 상태로 기능하지 못한다는 상실감, 사회적인 제약 때문에 우울해짐.

뇌졸중으로 인한 뇌 신경 증상도 우울증 발생에 기여한다는 견해도 있음.

#중풍 후 우울증의 정의 특징

1) 중풍 후 우울증 (Post-stroke Depression, PSD)

- 특별한 정신병력 없이 뇌졸중 발생 이후 우울증이 발생한 경우
- 중풍 후 발생하는 신경정신적 합병증 중 가장 흔함

2) 특징

- 우울증 발병일이 명확함
- 진행이 빠름
- 외부적 인자에 대한 반응이 부재
- 인지, 근력, 동기부여 등 여러 영역에 제한

#중풍 후 우울증의 구분

- 우울증 발생 시점에 따라 구분
 - 조발성(6개월 이내), 만발성(6개월 후)
 - 조발성이 만발성에 비해 심리, 신체 증상이 더 심각한 편
- 뇌졸중 후 기간별 PSD와 상관관계
 - 뇌졸중 후 3개월~2년 사이에서 우울해질 확률 : 1/3
 - 퇴원 후 3년 종단 연구에서의 유병률
 - : 3개월 25%, 12개월 16%, 24개월 19%, 36개월 30%

PSD와 기능장애, 인지장애

- 우울증으로 인한 피로, 절망감, 동기부여 감소가 기능장애를 더욱 악화
 - 우울증은 동기부여에 부정적인 영향을 미쳐 재활 참여율이 저하될 수 있음.
 - 우울이 2년간 ADL(일상생활능력) 회복을 방해하는 요인 중 하나

- 뇌졸중 후 우울증 환자는 뇌졸중이 있는 비우울 환자에 비해 기능장애 회복이 적으며 뇌졸중 후 처음 10년 동안 사망할 가능성이 3.4배 더 높음
- 우울증과 인지장애의 관련성으로 기억력장애, 주의력 및 정신운동 속도와 연관해마가 위축되기 때문.
- 우울증과 좌반구 병변이 있는 환자는 비슷한 병변을 가진 비우울증 환자보다 인지장애가 크다.
- 우반구 병변이 있는 환자에서는 유의한 차이를 발견할 수 없었다고 함.

뇌졸중 환자에서 흔히 보이는 3가지 유형.

-중증 우울증(우울증의 특징적인 증상들): 슬프고 식욕 없고, 수면장애, 집중력이나 자살사고

-경미한 우울증

-민감해지거나, 일상의 무관심, 냉정한 상태

AHA/ASA Scientific Statement ~Summary~

AHA, ASA는 협회 이름입니다.

- 역학: 뇌졸중 후 약 1/3에서 우울증이 발생할 수 있으며, 처음 1년 내에 가장 발생할 확률이 크다.
- 예측인자: 한정적이나 신체적 기능손상, 뇌졸중의 심각도, 우울증 병력, 인지손상과 관련
- 기능적 결과: 더 심한 기능손상을 일으킴. Fluoxetine이 PSD를 줄이고, 운동기능을 개선했다는 연구도 있음
- QOL: PSD는 QOL에 부정적 영향을 준다.
- 사망률: PSD에서 더 증가된 사망률을 보임
- 스크리닝: CES-D, HDRS, PHQ-9에서 더 높은 민감도를 보였으나 한정적임.
- 약물적 치료: 항우울제가 PSD에 효과적
- 심리사회적 개입 또한 중요
- 적절한 정보 제공이 약간의 이익을 줄 수 있음.
- 예방
- 약물적 예방: 항우울제가 PSD를 예방하는데 효과적이라는 사례들이 보고됨
- 예방으로의 심리사회적 개입 또한 효과적이라는 보고가 있음.
- 그러나 추가 연구가 필요함.

중풍 환자의 심리행동치료

- 질병에 대한 지식을 환자에게 가르쳐 주어야 함.
- 재활기는 환자의 신체, 사회와 심리의 여러 방면에서 조정하고 적응하는 단계. 환자에게 회복하겠다는 동기를 부여하여 심리적인 의존성을 벗어나게 함으로써 환자가 능동적으로 재활치료에 참여하도록 유도.
- 바이오피드백 치료로 자신의 심박동률, 혈압, 근육 전기반응을 제어하는 것을 습득하게 하여 심신이완, 안정 유지하도록 함
- 기타 음악, 명상, 향기요법 등으로 심신 안정.

#PSD와 관련된 한의학 논문

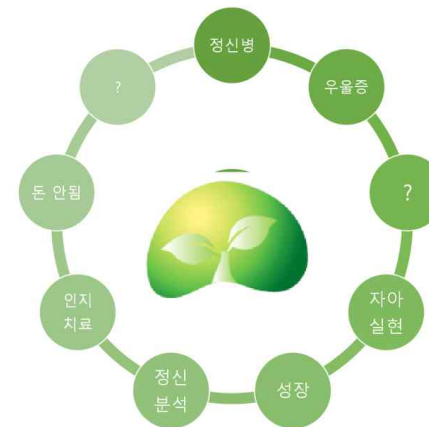
문헌고찰 위주가 대부분

- 치료기간: 1~12주로 다양, 6~8주인 논문이 가장 많음
- 백회>내관, 삼음교, 태충 등
- 감맥대조탕
- Wuling capsule, 가미소요산, 반하후박탕, 시호가용골모려탕 등 활용

[2] 정신사회적 치료

정신사회적 치료는 내용이 방대하니 간단히 소개한다.

Psychotherapy - What, How?



심리치료는 무엇이고 어떻게 하는 것일까?

정신병, 우울증에 사용할 수 있음

자아실현에 대해 질문할 수 있고.

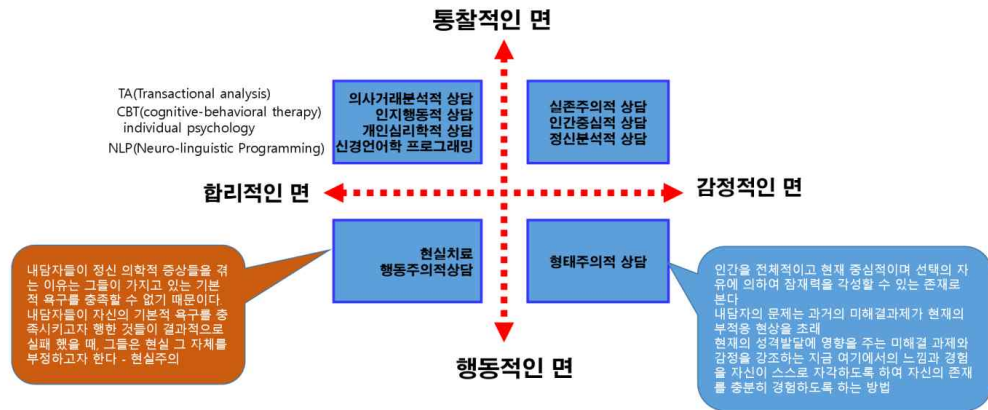
성장을 위해 진행할 수 있고,

정신분석이나 인지치료

한편으로는 돈이 안 되기도 함.

이러한 여러 가지 고민을 느낄 수 있다.

심리치료 비교



심리치료는 크게 통찰적인면, 행동적인 면 / 합리적인면, 감정적인 면의 4가지로 나누어 본다.

- 합리적이고 통찰적인 치료: 인지행동 치료, 개인심리학, NLP등
- 행동적이고 합리적인 치료: 현실치료, 행동주의적 상담

*현실치료: 내담자들이 증상을 겪는 이유는 기본적인 욕구를 충족시킬 수 없기 때문. 욕구 충족을 실패했을 때 그를 부정하고자 하기 때문에 병이 발생한다.

- 통찰적이고 감정적인 치료: 정신분석, 인간중심적 상담, 실존주의적 상담
- 행동적이고 감정적인 치료: 형태주의적 상담

*형태주의적 상담: 인간을 전체적이고 현재 중심으로 봐서 선택의 자유가 있고 잠재력을 가지고 각성할 수 있는 존재로 본다. 과거의 미해결과제가 현재의 부작용 현상을 초래해서 지금 여기에서의 느낌과 경험을 잘 자각하도록 한다.

정신분석	인지행동적 상담	인간중심적 상담	행동적 상담
- 과거를 중요시 - 정서적 통찰 - 장기상담	- 인간은 자극을 어떻게 지각하느냐에 따라 반응이 달라진다. - 문제자체의 해결이 중요 - 단기상담	- 문제보다는 내담자에 초점	- 인간은 단순히 자극에 대하여 반응한다. - 인간을 기계론적으로 파악

위와 같은 심리치료의 흐름이 있었는데, 요즘은 mindfulness를 결합한 3세대가 흐름이다.

심리치료의 종류

1. 최면요법

- 일종의 암시요법, 상상, 심상, 주의 등의 내재적 능력을 유도하는 도구
 - **시술자**의 지시에 따라 행동, 자기 통제력이 제한된 일종의 해리상태
 - 보조적 치료의 형태 : 태도나 증상의 변경, 무의식의 발굴
- 해결 중심으로 진행하고, 소파에서 눈감고 과거로 들어가는 이미지. 알고 있지 못하는 공포증, 혐오증이 있을 때 사용.

2. 자율훈련 (Autogen Training)

- Schultz가 **최면**의 정신생리학적 기전을 검토해서 그 본태가 근육과 혈관의 **이완**에 있다는 것을 알고 1932년에 제창.
 - **주의집중과 자기암시의 연습을 거듭함에 따라서 전신을 이완시키고 이것을 통해서 心身의 상태를 자기조정해가는 것. 자기조정력을 키워나가는 것!**
 - 외부의 도움없이 스스로에게 말을 건네며 의식을 집중함으로써 이완상태에 진입
- 최면요법과 달리 시술자가 없다!

아우토겐 트레이닝

- 각 단계의 암시어를 6번씩. 눈을 감고 2-3회 심호흡.
“기분이 대단히 편안하다” 머리속에서 천천히.
불면환자에도 활용 가능. 누워서, 앉아서 상관 없음. 이완하는 것이 포인트
한 주에 한단계씩하고 마지막에는 한꺼번에 6단계를 할 수 있도록 한다.

• 1단계 - 오른손이 무겁다 (중감)

실제로 오른손이나 왼손이 무겁게 느껴지는 경우가 많습니다. 연습이 진행될수록 사지가 다 무겁게 느껴지기도 합니다.

• 2단계 - 오른손이 따뜻하다 (온감)

연습이 잘 되면, 실제로 손의 온도가 1도가량 올라갑니다.

• 3단계 - 심장이 고요하고 힘차게 똠다 (심장조정의 연습)

이 암시어는 다양하게 변형할 수 있습니다. 평소 심장이 두근거리는 분들은 “심장이 고요하고 편안하다” 정도로 바꿀 수 있습니다.

• 4단계 - 호흡이 깊고 고요하다 (호흡조정의 연습)

이 암시어도 변형이 가능합니다. “호흡이 깊고 편안하다” 도 좋고 “호흡이 깊고 고요하다” 도 좋습니다. 간혹 호흡이 더 불편해진다고 하는 경우들도 있는데, 그럴 땐 조금 더 편안하게 해도 괜찮습니다.

• 5단계 - 태양신경총이 기분 좋게 따뜻하다 (복부의 연습)

태양신경총이란 단어가 생소한 사람들도 있습니다. 그럴 땐 “윗배가 기분 좋게 따뜻하다” 라고 해도 좋고 “위장이 기분 좋게 따뜻하다”고 해도 좋습니다.

중완 위쪽의 위치

• 6단계 - 이마가 시원하다

3. 지지정신요법

• 어떤 형태의 정신치료에는 간에 꼭 끼어드는 것으로, 치료자와 환자 사이에 마음 놓고 통할 수 있는 관계(rapport)가 그 근본바탕이다.

• **안심시킴, 지지, 환기, 제반응(정화), 설득, 암시** =지언고론요법

① 근본적으로 건전한 성격을 지닌 사람이 감당 못할 스트레스를 받아 동요를 일으키고 있을 때 단기응급처치를 하는 수단으로 쓰인다.

② 경계선성상태의 환자나 의존적성격의 환자에게 균형을 바로잡아 주기 위해 1차적·장기적인 치료방법으로 쓰인다.

③ 철저한 정신치료가 필요하나 당장은 그것을 감당할 만큼 자아가 강하지 못할 때 자아를 강하게 해주기 위한 방법으로 쓰인다.

정신치료는 마주하고 싶지 않은 과거의 힘든것을 다시 보면서 정리하는 과정인데, 자아가 감당이 안되고 불안하면 지지정신요법을 사용한다.

④ 철저한 정신치료를 받는 도중 갑자기 감당 못할 정도의 불안이 엄습해 오는 경우에도 잠정적인 치료수단으로 쓰인다.

4. 정신분석요법

원래 이것만 몇 년 배웁 정도로 굉장히 광범위한 내용.

• S. Freud의 창시 이래 정신요법의 주류.

1) 치료원리

- **치료자·환자 관계 속에서 과거의 대상관계를 재현**하여 거기에서 일어나는 諸現象(저항·전이)을 통해서 자기의 무의식과정 속의 하나하나를 통찰해가는 것으로 말미암아 personality(id·ego·superego)의 수정이나 성장을 목표로 하는 것이다.

2) **치료기법** : 자유연상법에 의하지만 그 전에 치료계약을 맺을 필요가 있다.

① 치료계약

• 수 회의 예비면접에서 환자의 병력·생활사를 상세히 청취해서 정신분석요법의 적응을 정하고 치료법의 개략, 횟수, 시간, 요금 등을 설명하고 환자와 약속한다.

계약은 치료 자체의 프레임은 만드는 것이다. 환자와 치료자의 경계를 철저히, 엄격히 만든다. 서로 주도적인 관계 안에서 평등하게 계약한다.

치료의 틀을 공고히 하고 유지하는 것이 환자에게 안정감이 들게 한다.(예: 원래 50분 상담인데 시술자가 한가하다고 /시간반 해주면 환자가 불안하다. 지각해도 남은시간만 상담해주고, 펑크내도 비용을 지불해야한다.)

치료에 늦거나 안 오는 것은 무의식의 저항으로 보아 통찰한다.

② 자유연상법

옛날에는 카우치에 누워서 했지만 요즘에는 그냥 마주 앉아서 한다.

• 조용한 방에서 환자는 침상에 반듯이 눕고 분석자는 그 머리맡에 앉아 있는 몸자세로 면접을 하여 환자 시야에 치료자가 들어오지 않게 하는 바, 그 이유는 전이현상을 극소화하고 자유연상을 촉진하며, 특히 편안하게 누운 자세라서 잡다한 관념·느낌이 의식에 잘 들어오기 때문에, 즉 백일몽·환상을 더 쉽게 한다는 데에 있다. 자유연상법의 기본원칙은 환자가 무엇이건 머리에 떠오르는 것을 그 순서대로 정직하게 말로 표현하는 것이다.

③ 분석자의 역할

• 환자에 대한 문제의 소재와 그 기원을 냉정히 알기 위해서 자기의 인생관이나 가치관에 좌우되지 않는 중립성의 입장에서 환자의 말에 찬성도 반대도 하지 말고 듣

고 있다. 분석자가 적극적으로 관여하는 것은 치료과정에서 저항이나 전이가 생겼을 때 그 의미를 환자에게 묻고 통찰시키기 위한 해석을 줄 때이다.

정신분석적 관점 = psychoanalysis, psychodynamic

- 고전적 정신분석 : Freud
- 심프로이트 학파 : Erikson, Adler, Jung, Sullivan, Horny
- 심리사회적 발달과 대인관계의 중요성을 강조
- 원초아 << 자율적인 자아의 기능을 강조
- 대상관계이론 : Fairbairn, Mahler, Kohut
- 자아기능의 강조
- 초기 대인관계 경험(아기-부모)의 질의 중요성을 강조 (pre-oedipal period)



• 심리적 문제의 발생과정 : 정신적 갈등과 자아의 방어과정

- ✓ 방어기제와 정신병리
- 편집증: 투사
- 성격장애:
 - ▶ 경계선 성격장애 - 분열, 부인, 투사적 동일시
 - ▶ 연극성 성격장애 - 부인, 동일시
 - ▶ 반사회성 성격장애 - 행동화(acting out)
 - ▶ 불안장애 : 전치, 반동형성, 신체화
 - ▶ 강박증(OCD) : 소거(undoing), 행동화, 투사 자주 사용.
 - ▶ 우울증 : turning against self(TAS)
 - ▶ 공격성 : 퇴행, 전치, 보상, 억압과는 부적상관

▶ 조울증 : 조증방어(manic defense), 과잉보상

투사적 동일시: 감당하기 힘든 감정들이 자신의 내부에서 오는 것이 아니라 밖에서 온다고 생각해 다른 사람을 통제하려 함.

조증방어: 불편한 생각이나 감정을 접했을 때 의식적으로 다른 곳으로 마음을 돌리면서 가만히 있지 못함.

과잉보상: 남보다 내가 우월하다는 식의 합리화

전통적 정신분석치료

• 문제의 원인

- 자아, 원초아, 초자아 간의 비효율성 → 과도한 방어기제를 사용한 결과

• 치료 목표 : 무의식의 의식화, 자아기능강화

- 무의식을 탐색하여 잘못된 심리성적 발달로 인해 생겨난 성격적 갈등을 이해, 통찰하고, 연습 → 기본적 성격구조를 효율적이 되도록 재구성하는 것이 목표

무의식은 그림자와 같다(잘 보이지 않지만 따라다닌다) 이를 알아차리는 것만으로도 의식에 확장이 일어나고 인생을 살아가는 본질적인 목표가 된다.

① 무의식의 의식화

: 억압하여 무의식화함으로써 전혀 의식할 수 없었던 무의식적 충동이나 욕구들에 대한 인식과 이해

보통 꿈이나 말실수에서 무의식이 드러난다. 억누르기 위한 방어기제들이 나타난다. 이것들을 알아차려기는 과정이 정신분석 치료!

② 자아의 기능을 강화

: 현재의 행동, 감정, 사고들이 무의식적 충동들에 의해 지배

⇒ 현실에 바탕을 두고 진행될 수 있도록 본능이나 충동들을 자아의 통제하에 두게 됨

• 정신분석 치료에 적합한 사람들

- 자아의 힘

: '인간관계를 오래 유지할 수 있었는가?'

: '인생의 어려움이나 변화에 직면했을 때 잘 견뎌냈는가?'

- 이드의 기능

: '어느 시기의 충동이 더 지배적인가?'

：이드의 욕구가 지나치게 억제되었거나 체질적으로 약해서 정신 에너지가 빈약하면 치료 작업은 어려워진다

- 초자아 기능：심각한 자살 위험, 심한 자기파괴욕구나 자해행동
- 이전의 치료효과：과거의 치료적 노력과 진행, 결과에 대한 자세한 정보
- 연령：젊은 성인(20~40세)이 정신분석에 알맞다
- 장애의 성질：질병으로 얻어지는 2차이득이 높은 경우에는 어렵다
- 현실여건：시간의 문제, 치료비용

• 치료의 과정과 치료적 기법

- 무의식에 대한 통찰은 오랜시간이 걸리는 것이 보통

- 자유연상

- 꿈의 분석

- 전이의 분석과 해결

※전이(transference)：‘그때 그 사람’에게 경험되었던 감정이 ‘지금 이 사람’(치료자)에게 재연되는 것

- 저항의 분석과 극복

※저항(resistance)：불안을 유발하는 기억과 감정들을 무의식적으로 억압하려는 모든 노력들

- 통찰(insight)：이전에는 전의식이나 무의식에 있어서 보지 못했던 개인의 정신적 감정적 갈등을 자각해 알게 된 것

아 내가 그랬었구나~를 알게 되면 달라질 수 있는데, 모르기 때문에 회피하고 저항하게 되는것

：지적통찰 / 정서적 통찰

- 혼습 working through *떨어졌던 상처를 소독하고 치료하는 과정*

：갈등과 불안이 일어나면서 일시적으로 증세가 악화되었다가, 뒤이어 무의식에 숨겨왔던 것들을 더 많이 자각하게 되고, 이에 따라 부분적으로나마 갈등이 해결되고 불안이 감소되는 식의 주기가 반복적으로 일어나는 과정

：혼습과정에서 분석가의 일은 내담자가 갈등을 잘 이해하도록 설명해 주는 것이며 그렇게 해서 최대의 통찰을 갖게 하고 자아가 통합한 영역이 확대되도록 도와주는 것

신프로이트 학파

▶ Adler의 Individual Psychology

：열등감을 극복하지 못하면 열등감 콤플렉스로 인해 고통 받으며 정신병리로 발전
：열등감을 보상하려는 방법에 초점을 맞추고 치료를 진행

▶ Sullivan의 Interpersonal Theory

：갈등은 본질적으로 대인관계(상실에 대한 불안)에서 옴.
：타인과의 상호작용을 통해 자기 개념을 형성하게 되며, 타인의 인정을 받으려는 노력을 통해 성격이 형성

개인심리학(individual psychology) - 알프레드 아들러

“ 어떠한 경험도 성공이나 실패의 원인이 되지 않는다. 우리는 소위 트라우마라는 충격을 겪지 않는다. 그저 자신의 목적에 맞는 것을 만들어낼 뿐이다. ”
트라우마란 없다!고 주장

- 1870년 비엔나 출생. 안과 의사로 시작
- 1902년에 프로이트를 만남. 비엔나 정신분석학회.
- 아들러는 인간 행동의 본질적인 조절 요소가 성적인 것이라고 믿지 않았다. 그는 무의식의 절대적 결정론을 믿지 않았다.
- 프로이트와는 달리, 아들러는 인간의 기본적인 욕구는 성적 본능이 아닌 **의지력**이라고 생각했다. 니체의 철학은 아들러의 철학에 강하게 영향을 주었다.

• 동시에, 알프레드 아들러는 우리의 최초의 경험이 무의식 속에 머물면서 우리의 훗날 정신적 삶을 결정한다는 생각을 거부했다. 반대로, 그는 현재와 지금의 삶의 방향과 의미를 부여하는 개인의 능력에 엄청난 가치를 두었다. *here and now*

- 보상：잠재력을 발휘하도록 인간을 자극하는 건전한 반응.
- 각 개인의 주요 추진력은 의지력이다. 개인은 새로운 잠재력을 개발함으로써 자신의 열등감에 대해 보상한다. 열등감에 사로잡혀 건강하지 못한 우울감 키운다. (냉소, 좌절, 무관심, 범죄)

• 열등감：자기 완성을 위한 필수요인

- 기질, 기능, 사회 혹은 과거의 경험 때문에 권력으로 향한 의지가 자극 → 우월성 추구
- 인간생활의 궁극적 목적 : 우월 = 한 단계 더 높은 단계로 나아가려는 역동
- 완전성을 향한 추구 → 완성
- 열등감 극복만이 적극적으로 향상과 완성으로 나아가는 것
- 인간의 동기는 미래에 대한 기대에 달려있다.
- 출생순위는 중요한 사회적 영향력으로 작용한다
- 출생순위에 따라 상이한 부모의 양육태도에 노출
- 아들러의 개인심리학은 **아동지도, 부모교육** 분야, 파괴적 생활양식을 가진 사람을 돕는데 광범위하게 적용

프로이드와 아들러 비교

프로이드	아들러
객관적	주관적
이론의 생리학적 토대	<u>사회심리학</u>
행동의 인과론, 결정론	행동의 목표지향적 강조
<u>환원주의</u> (원초아-자아-초자아 의식-무의식으로 나뉨)	<u>총체주의</u> (성격의 통합)
인간은 기본적으로 <u>악하다</u>	창조적이고 선택할 수 있는 존재, 그의 평가에 따라 선택할 수 있다.
정신내적 조화를 이루는 것이 심리치료의 이상적 목표이다.	자기실현 및 사회적 관심이 심리치료의 이상적인 목표이다.
인간은 적이다. 그들은 우리의 경쟁자이므로 우리는 그들로부터 우리를 보호해야함	다른 사람들은 동료이다. 그들은 우리와 동등한 사람이며, 인생에서 도움을 주는 사람
신경증의 원인은 성적인 문제가 원인이다.	신경증은 학습의 실패이며, 왜곡된 지각의 산물이다.

대상관계 이론

- **자아기능의 강조**
- **초기 대인관계 경험의 질의 중요성**을 강조 (pre-oedipal period)
= 어릴 때의 대상관계가 성인의 정신생활에서도 계속된다는 이론 → 초기 어머니와의 관계를 중시
- **Melanie Klein**
- 중요한 대상과의 관계에서의 경험에 따라 자신과 타인에 대한 표상을 발전시킴
- **Mahler의 자기 발달의 단계**
- 분리개별화 단계 : 4개월 ~ 24개월
분리개별화 : 아기가 엄마와 자신이 독립된 개체라는 것을 알고, 분리되는 과정
- 개인화 및 대상항상성 : 2세~ 자기와 완전히 분리된 대상을 인식, 자신과 타인에 대한 정신적 표상형성
대상항상성: 엄마가 잠깐 어디 다녀올 수 있다. 눈에 안보여도 없어지는 것이 아니다.
- **Kohut**
- 다른 사람과의 관계가 자기 인식의 발달에 중요함을 강조
- 대상으로부터의 공감적 반응이 개인의 생존과 심리 발달에 필수적인 것

단기역동치료

고전적 정신분석치료는 너무 장기적이라 현대사회와 맞지 않음. / 짧고 역동적으로 하는 치료.

전통적 정신분석치료	단기역동치료 (Short-term dynamic psychotherapy)
매우 장기적	시간이 짧음 : 대개 20-25회기 이내
	치료의 초점화-치료시간의 단축을 위해 신속한 사례의 개념화 : 주호소 문제 를 주로 다루게 됨
	치료자가 능동적 역할 - 제한된 시간 내에 목표에 도달하기 위해 중립성, 익명성 유지, 자유연상에만 의존하기 어려움 - 통찰을 위한 적극적인 방법들을 사용(해석, 직면, 명료화 등) - 이것이 효과적이기 위해 공감적, 신뢰관계 구축해야 함

정신분석이론에 대한 평가

- 공헌점: 무의식의 중요성, 초기 아동기 경험의 중요성 강조
- 비판점: 검증가능성의 부족, 일반화의 문제
- 현재 진료시 정신분석상담치료를 행하지는 않고, 이러한 정신분석적인 배경파악이 환자의 내적 심리를 이해하는데 많은 도움이 된다!

여기서부터는 이비안한의원 특강인데 들리는 것만 간단히 정리했으니 관심있는 사람은 보세요~ 시험에는 안나옴!

1. 민예은 원장님

1) 한의대 시절 했던 고민?

보건의료계 전체에서 한의사가 마이너에 해당하는 듯하고, 나이가 많아야 잘 먹히는 것 같고, 당시 한의대에 여자가 적어서 본인은 마이너의 마이너의 마이너인 듯 했다. 그 시절 one and only라는 키워드를 상정했다. 날카로운 송곳만이 두꺼운 얼음을 깰 수 있다. 어느 특화를 해야할까 고민했다.

2) 이비안한의원

2018년 8월8일에 개원.

아버지가 한의사라 한 세대를 경험하며 많은 브랜드가 흥했다 망하는 것을 보았다.

무한한 브랜드를 만들고 싶어서 8월8일에 개원했다.

한방병원 승계를 포기하고 0부터 시작.

동네한의원을 전국구 특화 한의원으로.

중점과목 치료건수 전국1위

<이명난청 완치설명서> 집필.

건강주권을 회복하는 것이 본질적 가치.

한의사의 이미지도 리브랜딩이 필요함.

이비안 여자 원장들의 컨셉은 현대판 의녀대장금.

특화 한의원이 외로운 미치광이처럼 보일 수 있는데 그 시간을 견뎌내는 것이 중요하고 함께하는 사람이 중요하다.

2. 이지수 원장님

이명의 통합의학적 접근

1) 이명이란?

이명: 외부의 소리자극 없이 귓속에서 소리가 들리는 것.

10~15%가 경험함.

원인을 추정할 수 없는 경우가 30%.

2) 이명의 기전

유모세포: 내이의 달팽이관에 위치하며 소리 진동에 따라 움직이는 섬모.

소리를 신경세포로 전달해주는 역할

유모세포 손상과 청각신경로의 보상기전 때문에 이명이 발생하는 것으로 봄.

유모세포 중 일부가 손상되면 특정 주파수대의 소리를 제대로 듣지 못함. 이로 인해 청각세포를 더 과민하게 인지하고 복구하려는 보상작용으로 인한.

3) 이명의 분류

- 객관적 이명: 귀 주변 혈류, 근육, 턱관절 이상 등으로 인한 것으로 타인에게도 들림.

- 박동성 이명

‘귀에서 심장소리가 들려요.’ 자세에 따라 바뀌는 것이 특징적.

청력이 정상인 것이 특징이고 귀와 목 주변의 긴장도를 확인해야함.

- 주관적이명: 청신경로 내에서 소리가 나는 것으로 환자에게만 들림.

-스트레스성 이명

열이 머리와 얼굴에 집중되어 압력이 높아지고 염증이 생겨 내이의 유모세포가 손상 됨

-갱년기 이명

4) 이명환자가 겪는 문제점

일상이 크게 바뀌고 무섭고 두려움

이명이 지속되며 유발되는 감정

: 수면장애, 집중력 저하(조용한 곳만 되면 이명이 들림), 정신신체적 및 대인관계 문제. -> 우울증으로 이어질 수 있음.

5) 이명의 양방치료

- 약물적 치료

-은행잎 추출물, 혈관확장제, 혈액순환개선제, 항혈소판제,

-> 귀로 가는 혈류량을 높이기 위함.

-항불안제, 신경안정제 등

=> 증상 호전률이 낮으며 루틴처럼 처방됨.

- 수술적 치료: 와우신경 절제술 등 => 권해지진 않음

- 보청기 착용: 청각신호를 강화해서 이명을 가리는 작용

=> 부정적 인식. 권유받게 되면 거부감을 느낀다. 음향학적인 문제에 대한 적응장애가 나타남. 사용률이 현저히 떨어짐.

- 이명 차폐기 사용

: 소음으로 이명을 가리는 것.

=>양방 이비인후과 진료 후 무책임하고 고통을 무시 받는 느낌을 받는다고 함.

6) 이명의 한방치료

이명의 원인이 되는 귀질환이 명확한 경우 질환치료가 선행되어야 함
귀질환을 발견하기 어려운 경우 통합적으로 치료하는 관점이 필요함.

- 고해상도 미세청력검사

이명은 다양한 소리로 나뉘는데 이를 잘 알아내기 위해 미세청력검사를 한다.
일반적으로는 6밴드 청력검사를 하는데, 6개 구역만 하기 때문에 나오지 않는 경우가 많다.

이비안에서는 67밴드 청력검사를 시행한다.

- 맥진검사

- 체열검사: 전신 순환을 확인. 귀 부분이 파랗게 나오는 것이 특징적- 귀로 가는 혈류가 저하되어 있다.

- 치료 - 건강환경 조성

영양: 활청탕, 사향공진단, 신경재생 약침치료.

순환: 활청외치요법. 골타요법, 추나초법을 통합

운동: 소리재활치료. 환자가 느끼는 이명소리와 가장 유사한 소리를 제작해 유모세 포가 움직일 수 있도록 한다.

7) 이명환자가 해서는 안되는 습관

조용한 장소 피하기; 이명이 고착화 될 수 있음.

극도의 긴장, 스트레스 상황 피하기

불안함에 빠지지 않기

이명에 집중하지 않기

귀 청소하지 않기

정신적, 육체적 피로 피하기

8) case

①사격훈련과 전산실 근무로 소음 노출 잦은 사람
1개월간 한약, 침, 소리치료 후 청력 회복

②별무계기 양측 이명 생긴 여성 환자

한달 치료 후 청력 회복, 소리치료 하향역치가 변화
귀가 잘 들리게 됨

돌발성 난청의 통합 의학적 접근

1) 돌발성 난청이란?

확실한 원인 없이 3일 이내 갑자기 발생하는 감각신경성 난청.

3개 이상의 연속된 주파수에서 발생.

이명, 현기증, 이충만감 동반

대부분 원인을 찾지 못하나 바이러스 감염과 혈관장애가 주된 발병기전.

2) 예후

- 1/3은 완전 회복 1/3은 불완전 회복 1/3은 영구 청력 소실

=>절망적인 상황이 2/3 이상에서 발생

- 예후 불량인자

급성기 회복이 느릴수록, 청력손실 심할수록, 치료 늦게 시작할수록 불량

- 조기진단, 조기 치료가 가장 중요하다!!

귀가 갑자기 먹먹하다 <<- 환자가 호소하는 증상. 빠르게 이비인후과나 이비안에 가야함.

(전음성 난청을 배제해야함)

3) 돌발성 난청 환자가 겪는 문제점

아침에 일어났는데 물먹은 솜이 한쪽 귀를 막은 느낌이 든다. 너무 우울해짐.

4) 돌발성 난청의 양방치료

- 경구스테로이드

: 명확한 근거가 부족하지만 2주 이내 초기치료로 제공가능하고 표준 치료제로 사용

됨. 혈당 상승, 간수치 상승 등의 부작용

- 고실 내 스테로이드 주입(고막주사)

: 스테로이드로 부작용이 생기거나 스테로이드 써도 효과없는 사람에게.

부작용으로 고막천공이 있고 효과도 별로

- 고압산소치료

: 발생 2주 안에 스테로이드와 병행하여 시행. 대기압보다 2~3배 높은 산소통에 들어가는 치료. 부작용 있음

- 기타약물치료: 항바이러스제, 혈전용해제, 혈관확장제 등을 쓰는데 진단 확실해야 쓴다.

- 그러면 보청기, 인공와우가 답인가?

요즘 보청기 리베이트가 심해서 보청기를 잘 권유하는데 그러면 안된다!

인공와우는 보청기를 사용해도 전혀 들리지 않는 청각장애 2급 이상에서만 제한적으로 해야함.

- 돌발성 난청의 양방 치료 요약

=> 이렇다 할 치료방법이 없다! 빠른 경우 한 달 만에 치료를 중단하기도.

5) 돌발성 난청의 한방치료

오아시스에 논문이 아주 많다.

- 돌발성 난청의 침치료

: 침술은 국소 혈액 순환을 개선하고 혈액 점도를 감소시킬 수 있어 난청에 도움이 됨. 스테로이드와 병용 시 부작용을 일으키지 않으면서 효과를 낸다.

- 한방 복합치료의 가치

: 약에서 경향성은 없음(환자 개개인의 특성에 따라 변증해서 처방) 삼일신기환, 육미지황탕, 청심지황탕, 자음건비탕, 보중익기탕 등이 사용.

- 한방 치료의 가치

: 기저질환을 치료하며 양방에서 포기한 경우를 치료해볼 수 있다. 스테로이드 못 쓰는 경우에 도움이 될 수 있다.

- 생활코칭

-충분한 수면과 휴식 / 음주, 흡연, 카페인 자제하기 / 자극적인 음식 피하기

-> 당연한 말 같지만 강조해야 한다. 드라마틱한 효과가 있을 수 있다.

6) case

① 양측성 돌발성 난청 환자 (원래 양측성은 드물다)

; 스테로이드 썼는데 별무호전해서 내원

치료결과 경도난청에서 4달만에 정상범위까지 올라갔다.

주관적 증상도 vas가 10에서 4로 떨어짐.

② 좌측 돌발성 난청 환자

활정순기탕 먹고 치료결과 혈액검사도 좋아짐.

안면마비 후유증의 통합 의학적 접근

1) 말초성 안면신경 마비=벨마비

헤르페스 type1 감염과 연관 된 것으로 알려짐

2) 안면마비 후유증의 이해

신경손상부위에 따라 후유증의 위치가 다름.

초기에 어떤 증상이 있었는지 파악하는 것이 중요.

3) 안면신경마비 임상진료지침

-경구 스테로이드. 72시간내에 복용하도록 권고.

-항바이러스제는 스테로이드와 병용했을 때만 유효.

-눈을 관리해야함. 잘 안감길 수 있기 때문에 시력장애 막기 위해

-감압술은 권고되지 않음

-침치료는 아직 연구가 부족함.

4) 후유증

치료의 골든타임을 놓치면 후유증이 발생할 수 있다. --> 신경이 합성된다!

-안면 비대칭, (마비측의 8자 주름, 한쪽 눈꼬리만 올라감 등

-안면 연축, 구축

-연합 운동: 눈을 감을 때 입이 같이 움직이는 등

-악어의 눈물; 침샘과 눈물샘 신경이 얹히면서 생김

5) 안면마비가 지속되며 유발되는 감정

조급 초조, 답답한, 불안감, 대인기피증

제한된 일상을 보내게 됨

6) 양방치료

- 보톡스

가장 많이 쓰임. 근육을 마비시키는 치료. 감각이 떨어져서 불편함.

대부분 정상측에 주입해서 마비측 근육에 힘을 쓰게 함.

- 눈꺼풀 추 삽입 수술

: 눈을 못 감을 때 쓰는데, 눈을 뜨기 힘들어지는 부작용이 있을 수 있다. '

- 도수치료

: 마비된 얼굴 근육에 감각 자극, 얼굴 근육을 이완시키는 역할.

도수치료가 매선이나 침치료보다 효과가 떨어진단다.

- 선택적 신경 차단술

: 연합운동이 심하게 나타난 경우 쓰는데, 모든 신경을 한번 씩 잡아당겨보는 수술이라 7시간 정도로 엄청 오래 걸리는데 효과가 좋지 않다.

- 수술 요법의 한계: 매우 침습적이고 부작용 유발 가능

반대측 정상 부위의 과도한 당김 증상을 유발함.

건측 신경을 땀겨서 마비측에 붙이는 경우도 있는데 이 경우 재활이 많이 필요함.

미묘한 안면 불균형을 교정하기 어려움.

7) 한방치료

도침, 매선침, 미세안면침 등

- 매선요법

가장 많이 씀.

장기간의 유침을 필요로 하는 경우에 씀.

- 미세안면침치료: 얼굴에 50~100개정도의 얇은 침을 놓음.

- 후유증에 대한 한방치료의 장점

비수술적으로 안면교정이 가능하고, 수술에 비해 시술에 간단해 일상화 병행이 가능함. 별도의 홈케어나 재활훈련이 필요하지 않고 부작용이 크지 않다.

8) case

①좌측 벨마비 후유증이 있다가 우측 초기 벨마비가 나타난 사람.

눈이 다 감기지 않고 이마가 안움직임 -> 호전

②좌측 구안와서 후유증 환자

마비의 정도가 심했음. 좌측 눈이 토끼눈이 됨(다 안 감겨서 빨개짐) -> 호전

③ 60년된 후유증을 새롭게 치료하려 한 환자

워낙 오래되어서 더디긴 하지만 호전 중

3. 이비안 한의원 인턴쉽

시간의 농도를 높여 최신 지견을 습득함.

마지막 학년을 임상현장을 위한 실전 연습으로 함.

기업에서 하는 인턴쉽이랑 비슷함.

1) 업무

①원내 교육자료 제작.

-한의학 임상 강의를 수강하고 강의록을 작성함.

-10대 특화질환을 총정리 함.

②참관진행 및 프로그램 관리,
-일정 조율, 실습 프로그램 안내, 참관후기 취합

③서적 및 논문 인사이트 정리.
- ‘이명난청리셋법’ 10분만에 읽기

2) 인턴ships을 통해

귀한 인연과의 만남
한의학에 대한 재발견
특화 진료에 대한 이해도 향상
성장하는 과정(책임감, 시간관리)
을 얻을 수 있었다.

3) 인턴ships 2기

업무

이비안 진료연구팀 춘계/추계 컨퍼런스 참여 및 증례발표(4월/10월 오프라인 미팅)
10대 특화질환에 대한 한의학/의학의 최신동향스터디(월1회 온라인 zoom 미팅)
여름방학중 1주 참관 및 타대학생들 참관관리

ebian_hrd@kakao.com 에 11월 16일까지 신청하세요
인터뷰 후 계약, OT를 거쳐 2025년 3월부터 업무 시작